



- DIAGNOSTIC TSA DE L'ADULTE - DISPOSITIF DE PREMIERE LIGNE

GUIDE D'ENTRETIEN CLINIQUE

Support pour guider l'observation clinique du TSA chez l'adulte sans déficience intellectuelle, à destination des praticiens de première ligne.

Ce guide accompagne les médecins de première ligne dans l'évaluation clinique du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle chez l'adulte. Il s'inscrit dans le **Dispositif de Première Ligne (DPL)** porté par l'unité mobile autisme adulte *Les Makaras*, et vise à soutenir la démarche diagnostique tout en réduisant les délais d'accès aux équipes spécialisées, réservées aux situations complexes.

C'est un **appui au raisonnement clinique, non un test** : aucun outil ni score ne pose à lui seul le diagnostic. Celui-ci repose sur une **convergence de signes**, leur **ancienneté développementale**, leur **retentissement** et leur **spécificité** (différentiels écartés), avec pour exigence constante de **minimiser les faux positifs**.

En préambule, des points de vigilance aident à la fois à **repérer** un TSA (signes évocateurs, histoire clinique, profil féminin souvent sous-diagnostiqué), à **identifier** les situations relevant d'emblée d'une évaluation experte (critères de complexité), et à **éviter les pièges** fréquents (camouflage surinterprété, autodiagnosics issus d'internet ou des réseaux).

Le cœur du guide repose sur deux temps complémentaires :

- **PARTIE 1 – Exploration clinique guidée** : objectiver les particularités compatibles avec un TSA lors d'un entretien structuré avec le patient (3 pages).
- **PARTIE 2 – Entretien avec un proche** : recueillir un regard tiers sur le développement et/ou le fonctionnement quotidien du patient, soit auprès d'un parent l'ayant connu vers 5–6 ans, soit auprès d'un proche l'ayant côtoyé durablement. (2 pages).

Des annexes complètent l'analyse selon les besoins : **Annexe A** (lecture illustrée des critères DSM-5), **Annexe B** (diagnostics différentiels et comorbidités — centrale pour éviter les faux positifs), **Annexe C** (grille d'observation des manifestations non verbales et sociales spontanées).

Dans le cadre du DPL, ce guide sert aussi de support structuré pour l'entretien téléphonique avec l'équipe de coordination, en vue de statuer sur l'issue du parcours (diagnostic confirmé, non retenu, ou orientation spécialisée). Il peut enfin documenter objectivement les démarches médico-sociales ultérieures, notamment les dossiers MDPH.

LES DRAPEAUX ROUGES

1

- SIGNES EVOCATEUR DES LA PREMIERE RENCONTRE -

Certains comportements, attitudes ou modalités de contact peuvent éveiller la suspicion d'un TSA, sans être forcément identifiés comme tels au premier abord :



Prise de contact inhabituelle : le patient envoie un long mail très détaillé, refuse les appels, insiste pour tout passer par écrit. La demande peut être formulée de manière rigide ou avec des attentes très précises.



Rapport au cadre de consultation : grande ponctualité, voire arrivée excessive en avance, respect strict de la durée ou refus de déroger à la structure prévue.



Langage inhabituel (tournures trop soutenues, littérales ou techniques ; impression que le patient « récite » un discours préparé) et **registre émotionnel peu ajusté** (ton monocorde, peu de variations prosodiques, sourires décalés ou absents)



Difficulté à entrer dans le lien relationnel : impression d'un « mur » ou d'un flottement dans l'échange, sans agressivité mais avec retrait, rigidité ou perplexité.



Présence « d'équipements » nombreux ou atypiques : certains patients arrivent avec de nombreux objets organisés (casque, banane, gourde, accessoires sensoriels...), traduisant une préparation minutieuse face à la situation. Cette apparente « armure » reflète souvent le coût anticipé de l'interaction sociale et le besoin de contrôle, sans lien avec une désorganisation d'allure psychotique.

2

- ÉLÉMENTS DE L'HISTOIRE CLINIQUE ÉVOCATEURS -

Certains éléments relevés dans l'anamnèse ou les antécédents doivent alerter le clinicien et motiver une exploration plus approfondie de la possibilité d'un TSA, en particulier lorsque les signes actuels sont discrets ou atypiques :



Antécédents de troubles du neurodéveloppement (TND) : suspicion ou diagnostic antérieur de trouble « dys » (dyslexie, dyspraxie, etc. => notion d'un suivi orthophonique ou en psychomotricité dans l'enfance ?), TDAH, ou trouble du langage oral.



Antécédents neurologiques : notamment une épilepsie (même ancienne), ou toute autre pathologie neurologique connue.



Dysmorphies évocatrices : hypertélorisme, anomalies de l'implantation des oreilles, de la lèvre supérieure ou autre signe facial atypique peuvent évoquer un trouble du développement d'origine génétique.



Parcours scolaire atypique : retard d'acquisition (langage, propreté, autonomie), redoublements, sauts de classe, aménagements ou aides spécifiques, harcèlement scolaire fréquent.



Antécédents familiaux de TND : TSA, TDAH, troubles spécifiques du langage ou des apprentissages chez des apparentés de 1er ou 2e degré.

3

- PROFIL FEMININ -

Le TSA sans déficience intellectuelle est fréquemment **sous-diagnostiqué chez les femmes**. Leur présentation clinique est souvent **moins typique, plus compensée** sur le plan social, et masquée par des **stratégies d'adaptation**.



Camouflage et imitation sociale : Elles peuvent avoir appris à « jouer un rôle » en public, en imitant les comportements attendus, au prix d'une fatigue psychique intense. Cette capacité d'observation fine peut donner une illusion de compétences sociales préservées.



Communication et adaptation apparente : Elles utilisent parfois davantage de gestes, de regards ou de mimiques, et peuvent manifester une forte motivation sociale. Leur scolarité et leurs interactions précoces peuvent paraître normales, malgré une incompréhension des implicites sociaux.



Intérêts spécifiques moins visibles : Leurs centres d'intérêt sont souvent plus socialement valorisés (animaux, psychologie, lecture...), ce qui les rend moins facilement identifiés comme restreints ou atypiques.



Expression internalisée du trouble : Les plaintes sont plus souvent anxieuses ou dépressives (TCA, crises d'anxiété, burnout), sans demande explicite autour de la sphère sociale. Le TSA peut être masqué derrière ces diagnostics partiels.



Discordance entre discours et vécu : Le langage est souvent fluide, mais la compréhension du second degré, de l'humour ou des sous-entendus peut rester superficielle ou rigide.



Errance diagnostique fréquente : Ces patientes consultent souvent pour d'autres motifs (TDAH, TAG, TCA, trouble borderline...), sans qu'un diagnostic global n'ait été posé. Le TSA est rarement suspecté d'emblée.

⚠ En entretien, ces patientes peuvent paraître adaptées, mais expriment une grande souffrance après-coup.

- CRITÈRES DE COMPLEXITÉ -

Certaines situations nécessitent un appui diagnostic renforcé ou une orientation vers un CRA/CDE, car elles compliquent l'évaluation standard. Elles doivent alerter le clinicien et justifier une demande d'expertise spécialisée :



Comorbidités psychiatriques majeures : antécédents de troubles psychotiques, thymiques sévères, ou pathologies neurologiques rendant l'évaluation difficile ou instable.



Handicap ou déficience associée : Présence de déficience intellectuelle ou de troubles associés (ex. sensoriels, moteurs...) altérant l'expression des signes autistiques.



Symptômes atypiques ou difficilement différenciables : Doutes persistants malgré l'analyse développementale, recoupements flous avec d'autres troubles du neurodéveloppement (TDAH, troubles du langage, etc.).



Histoire développementale inaccessible ou incertaine : absence d'interlocuteur fiable pour l'anamnèse, adoption, parcours de placement, événements traumatiques précoces.



Contexte social, familial ou juridique complexe : désaccord parental, troubles du lien, demande d'expertise médico-légale, suspicion de manipulation ou d'enjeux secondaires.



Demande de seconde expertise : Cas d'errance ou d'enchaînement de diagnostics partiels sans conclusion claire, avec retentissement fort.

⚠ Des outils d'aide à la décision existent, comme les questionnaires d'adressage élaborés par certains CRA permettant d'objectiver la pertinence d'une orientation

- PIEGES FREQUENTS A EVITER -

Dans les consultations de première ligne, certains biais ou automatismes peuvent entraver une évaluation fiable. Il est essentiel de conserver une posture clinique rigoureuse, centrée sur l'observation, l'anamnèse développementale, et la cohérence globale du tableau.



Camouflage social : Certains patients évoquent le fait de « masquer » leurs difficultés sociales. Si cette notion est reconnue dans le champ du TSA, elle ne doit pas être surinterprétée. Un diagnostic ne peut reposer uniquement sur un discours de camouflage : celui-ci doit s'appuyer sur une discordance objectivable entre l'apparente adaptation sociale et des limitations concrètes dans la réciprocité, l'intuition sociale ou la flexibilité.

⚠ Si l'évaluation ne confirme pas les critères du TSA, il est essentiel de remettre en question l'hypothèse diagnostique plutôt que d'attribuer l'absence de signes à un camouflage supposé.



Bilans réalisés sur internet, non exploitables : Il arrive que des patients se présentent avec un « diagnostic » fondé uniquement sur des auto-questionnaires ou des évaluations non standardisées. Ces outils peuvent contribuer à la réflexion, mais n'ont pas de valeur diagnostique en tant que telle.

⚠ Ces éléments ont une valeur informative et doivent être interprétés dans une démarche clinique structurée. Les bilans réalisés en libéral peuvent être utiles s'ils sont rigoureux, mais leurs conclusions peuvent parfois refléter la demande initiale du patient et doivent être analysées avec recul.



Influence des réseaux sociaux : De nombreux patients s'auto-identifient à des profils décrits sur TikTok, YouTube ou Instagram. Si cela peut refléter un véritable vécu, ces représentations sont souvent partielles, stéréotypées, voire erronées. Elles peuvent créer une forte attente de validation.

⚠ Le praticien doit veiller à ne pas calquer l'évaluation clinique sur ces représentations médiatiques. Le diagnostic doit reposer sur des critères validés, une anamnèse précise, et une observation clinique approfondie.

- PARTIE 1 -

EXPLORATION CLINIQUE GUIDÉE

Cette deuxième partie explore de manière structurée **9 thématiques cliniques** en lien avec les **critères diagnostiques** du TSA sans déficience intellectuelle. Elle complète l'observation directe par un entretien semi-dirigé, généralement réalisé **en 2 consultations d'environ 30 minutes (parfois 3 selon la complexité de la situation)**. L'un des intérêts du dispositif est de **s'appuyer sur la connaissance que le praticien a déjà de son patient**, parfois acquise au cours de plusieurs mois ou années de suivi. Idéalement, les éléments émergent d'un échange fluide ; à défaut, le praticien peut proposer d'aborder successivement les thématiques en s'appuyant sur les **questions-types** pour guider l'entretien. Une posture souple et naturelle est recommandée pour éviter un effet « formulaire ». **Les items peuvent être pré-remplis** si certaines informations sont déjà connues, afin de cibler l'exploration.

OUI

NON

-THEME 1 : LES EMOTIONS-

Nous recherchons un déficit d'identification et d'expression des affects, chez soi et chez autrui.

Registre émotionnel pauvre : peine à nommer des émotions au-delà de joie / tristesse / colère.

☒
☐

⚡ N'évoque pas spontanément peur, honte, fierté, frustration, soulagement... On vise la finesse du ressenti, pas le vocabulaire.

⦿ « Sur une journée ordinaire, quelles émotions est-ce que vous traversez ? Racontez-moi la dernière fois où vous avez ressenti quelque chose de fort — c'était quoi, exactement ? » « Racontez-moi la dernière fois où vous avez été vraiment remué — c'était quoi, comme émotion ? Il y en avait plusieurs à la fois ? »

Expression émotionnelle peu modulée (voix, visage, gestes).

☒
☐

⚡ Ton monocorde, visage peu mobile, gestualité rare malgré un contenu émotionnel — ou, à l'inverse, expression « surjouée » et décalée. À objectiver pendant l'entretien autant que par le récit.

⦿ « Quand quelque chose vous touche vraiment, comment ça se manifeste chez vous ? » (et observer la prosodie / les mimiques pendant la réponse) » « On vous a déjà dit qu'on avait du mal à savoir ce que vous ressentiez — ou au contraire que vous "en faisiez trop" ? »

Peu de langage imagé spontané pour parler du ressenti.

☒
☐

⚡ Décrit ses émotions de façon littérale, sans métaphore spontanée (« boule au ventre », « à bout »...). Attention : l'image peut être apprise — viser le spontané.

⦿ « Quand vous ressentez une émotion forte, comment vous la décririez, physiquement, dans le corps ? » « Si vous deviez faire comprendre cette émotion à quelqu'un qui ne l'a jamais éprouvée, vous lui diriez quoi ? »

Lecture des émotions d'autrui déductive plutôt qu'intuitive.

☒
☐

⚡ Pour savoir ce que ressent l'autre, s'appuie sur une analyse explicite (« je regarde si le visage change ») plutôt que sur une perception immédiate ; décrit parfois un effort conscient.

⦿ « Quand quelqu'un en face ne dit rien, comment savez-vous comment il se sent ? Ça vous saute aux yeux, ou il faut que vous y réfléchissiez ? » « À quoi vous vous fiez pour deviner l'humeur de quelqu'un ? Vous est-il déjà arrivé de vous tromper complètement sur l'état d'une personne ? »

-THEME 2 : LES CONVENTIONS SOCIALES-

Nous recherchons un décalage dans l'appréhension des conventions sociales, parfois implicites

Ne perçoit pas spontanément ce qui « se fait » ou « ne se fait pas » dans une situation donnée.

☒
☐

⚡ Transgresse des normes implicites sans intention (interrompt, parle trop fort, aborde un sujet déplacé), et le découvre après coup via la réaction des autres. À distinguer d'une transgression assumée ou provocatrice.

⦿ « Vous est-il arrivé qu'on vous reprenne parce que vous aviez dit ou fait quelque chose qui "ne se faisait pas" ? C'était quoi, la dernière fois ? » « Dans une situation nouvelle — un repas un peu formel, une réunion — comment vous faites pour savoir ce qu'il faut faire ou pas ? »

A besoin qu'on lui explicite des règles que les autres saisissent d'eux-mêmes.

☒
☐

⚡ Les sous-entendus ne « vont pas de soi » : demande pourquoi telle règle existe, suit les consignes au pied de la lettre. Le déficit porte sur l'implicite, pas sur l'intelligence.

⦿ « Y a-t-il des choses que les gens autour de vous semblent comprendre tout seuls, et qu'on a dû vous expliquer ? Un exemple ? » « Vous est-il déjà arrivé de faire exactement ce qu'on vous avait demandé, mais que ce n'était pas ce qu'on attendait de vous ? » (Littéralité face à l'implicite)

Applique les règles sociales de façon rigide, sans les moduler selon le contexte.

☒
☐

⚡ Même attitude quel que soit l'interlocuteur ; supporte mal qu'on « déroge » à une règle, même quand le contexte le justifie. À différencier d'un simple goût de l'ordre : ici la rigidité gêne l'ajustement social.

⦿ « Est-ce que vous vous comportez de la même façon avec tout le monde — un proche, un supérieur, un inconnu — ou ça change ? » « Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un ne respecte pas une règle que vous, vous suivez ? »

Commets des maladresses sociales malgré une réelle volonté de bien faire.

☒
☐

⚡ Remarques honnêtes mais blessantes, oublis de salutations / remerciements, franc-parler mal reçu — sans intention de nuire, et souvent sans comprendre ce qui a gêné. L'intention bienveillante distingue du mépris ou de l'agressivité.

⦿ « Vous est-il arrivé de dire quelque chose d'honnête et de voir la personne se vexer, sans bien comprendre pourquoi ? La dernière fois, c'était quoi ? » « Est-ce qu'on vous fait souvent des remarques sur votre façon de parler ou de vous comporter avec les gens ? »

-THEME 3 : LES RELATIONS SOCIALES-

Nous recherchons des atypies dans l'initiation, la réciprocité et la gradation des relations sociales (amitié, lien, intimité).

Difficulté à initier le lien : ne va pas spontanément vers l'autre.

☒
☐

⚡ Ne sait pas comment amorcer une conversation ou prendre contact, même quand le désir de relation existe. À différencier d'une timidité / anxiété sociale, où l'évitement vient de la peur du jugement (avec conscience du blocage), pas d'un défaut de « mode d'emploi ».

⦿ « Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, comment vous y prenez-vous pour entrer en contact ? » « C'est plutôt que ça ne vous intéresse pas d'aller vers les gens, ou que vous aimeriez mais ne savez pas trop comment faire ? »

Conception atypique ou appauvrie de ce qu'est une relation.

☒
☐

❶ Voit l'amitié de façon utilitaire (« à quoi ça sert »), ne saisit pas l'intérêt d'un échange « gratuit », ou vit les liens en tout-ou-rien (ami / ennemi). On explore la représentation du lien, pas le nombre d'amis. ○ « Pour vous, ça sert à quoi, un ami ? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation proche ? » « Vous arrive-t-il de discuter avec quelqu'un juste pour le plaisir de parler, sans but précis ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? »		
Évalue mal le degré d'intimité ou de familiarité adapté à la relation.	☒	☐
❷ Trop familier trop vite (« meilleur ami » après deux rencontres), ou au contraire distant là où de la proximité est attendue ; ne gradue pas selon le type de lien. C'est la netteté du décalage qui compte, pas une maladresse ponctuelle. ○ « Comment vous savez si quelqu'un est un proche, une simple connaissance, ou juste quelqu'un que vous croisez ? » « Vous est-il arrivé de vous sentir très proche de quelqu'un alors que pour l'autre ce n'était pas réciproque — ou l'inverse ? »		
Difficulté à entretenir les relations dans la durée ; liens souvent à sens unique.	☒	☐
❸ Les relations s'étiolent faute d'entretien (ne donne pas de nouvelles, ne relance pas), ou reposent entièrement sur l'autre. ○ « Vos amitiés, elles durent dans le temps, ou elles ont tendance à s'éteindre ? À votre avis, pourquoi ? » « Dans vos relations, qui prend des nouvelles, qui propose de se voir — vous, l'autre, les deux ? »		
- THEME 4 : LES RITUELS - Nous recherchons des rituels et habitudes personnels, précis et imposés, au-delà des routines communes.		
Façons de faire très personnelles et précises, au-delà des habitudes communes.	☒	☐
❹ Pas « avoir une routine » (universel), mais des rituels idiosyncrasiques sur des choses que la plupart des gens ne ritualisent pas : ordre précis pour manger les aliments, disposition exacte d'objets, même siège, séquences gestuelles. C'est la spécificité / l'étrangeté qui compte, pas l'existence d'une routine. ○ « Y a-t-il des choses que vous faites d'une manière bien à vous, très précise, que d'autres trouveraient inhabituelle ou inutile ? » « Par exemple à table, au travail, chez vous — est-ce qu'il y a un "bon" ordre ou une "bonne" disposition pour certaines choses ? »		
Nécessité de respecter / compléter la séquence.	☒	☐
❺ Si l'ordre est rompu ou une étape sautée : doit recommencer, se bloque, ou reste mal à l'aise tant que ce n'est pas « comme il faut ». On vise le besoin de complétude, pas une préférence. ○ « Vous arrive-t-il de devoir refaire quelque chose depuis le début parce que ça n'avait pas été fait exactement comme il faut ? Un exemple récent ? » « S'il manque un détail dans une de ces façons de faire, vous pouvez laisser passer, ou ça vous reste en tête tant que ce n'est pas corrigé ? »		
Impose ses routines ou son ordre à l'entourage.	☒	☐
❻ Exige que les autres suivent ses façons de faire, ou que rien ne soit déplacé / changé ; tensions quand ce n'est pas respecté. ○ « Est-ce que votre entourage doit s'adapter à certaines de vos façons de faire ou de ranger ? » « Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne le respecte pas, ou déplace vos affaires ? »		
Préférence systématique pour l'identique.	☒	☐
❼ Revient toujours aux mêmes vêtements, aliments, trajets, places, activités ; préfère le connu au nouveau pour le contenu lui-même (pas seulement l'ordre). ○ « Pour ce que vous mangez, portez, ou vos trajets — vous variez, ou vous revenez souvent aux mêmes choses ? » « Au restaurant, ou devant un choix nouveau, vous prenez ce que vous connaissez déjà, ou vous testez ? »		
- THEME 5 : L'IMMUABILITE - Nous recherchons une intolérance au changement et à l'imprévu, distincte de l'inquiétude anxieuse.		
Besoin d'anticiper, de connaître le déroulé à l'avance.	☒	☐
❶ Veut savoir précisément comment les choses vont se passer, pose beaucoup de questions sur le programme, supporte mal le « on verra ». À distinguer du souci anxieux : ici c'est le besoin de structure connue, pas (seulement) la peur d'un mauvais résultat. ○ « Quand vous allez vers une situation nouvelle, vous avez besoin de savoir à l'avance comment ça va se dérouler, ou vous y allez sans trop y penser ? » « Est-ce que vous préparez les choses dans le détail à l'avance — plannings, listes, vérifier le trajet ? »		
Détresse ou désorganisation face à l'imprévu.	☒	☐
❷ Un changement de dernière minute (rendez-vous décalé, trajet modifié, programme bouleversé) déclenche une réaction forte ou un blocage hors de proportion. On vise la désorganisation — saturation par le changement —, pas une simple contrariété. ○ « Que se passe-t-il pour vous quand un plan change à la dernière minute ? » « Repensez à une fois où quelque chose a été modifié au dernier moment — comment vous l'avez vécu ? »		
Évitement de la nouveauté.	☒	☐
❸ Repousse, annule ou refuse les activités / lieux / situations nouveaux ; préfère le connu par appréhension du non-balisé. À distinguer de la phobie sociale (évitement du regard des autres) : ici c'est l'inconnu, le non-cadré, qui est évité. ○ « Devant quelque chose de nouveau — un lieu, une activité jamais faite — vous avez plutôt envie d'essayer, ou de l'éviter ? » « Vous arrive-t-il de repousser ou d'annuler des choses parce qu'elles sont nouvelles ou pas balisées ? »		
Récupération coûteuse après un changement	☒	☐
❹ Après un imprévu, a besoin de temps et d'un retour à un cadre connu pour se réorganiser ; la perturbation « traîne » bien après l'événement. C'est le coût de récupération qui est exploré ici, pas le rituel lui-même ○ « Après qu'un imprévu vous a bousculé, vous vous remettez vite, ou il vous faut du temps pour vous réorganiser ? » « Qu'est-ce qui vous aide à reprendre pied quand quelque chose vous a déstabilisé ? »		
- THEME 6 : L'INTERET RESTREINT - Nous recherchons un intérêt d'intensité ou de focalisation anormale : ce qui compte n'est pas le sujet, mais sa centralité et sa charge émotionnelle. L'intérêt peut changer, mais domine à chaque période.		
Centre(s) d'intérêt fortement investi(s), parfois atypique(s).	☒	☐
❶ Le sujet peut être inhabituel (horaires de trains, taxonomie, un système) ou très ordinaire et valorisé (animaux, psychologie, une série, une cause) — fréquent et trompeur chez les femmes. Ne pas se fier au contenu. ○ « Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment ? Y a-t-il un sujet qui prend une place particulière pour vous ? » « Au fil de votre vie, y a-t-il eu des sujets ou des passions qui vous ont vraiment absorbé pendant une période ? »		

Connaissance accumulative et systématisée du sujet.	☒	☐
⌚ Accumule des faits précis, catalogue, classe, corrige les erreurs ; la collection d'informations vaut parfois pour elle-même. À distinguer d'une simple bonne culture (HPI, passionné) : ici l'engagement est exhaustif et systématisant. ⌚ « Sur ce sujet, qu'est-ce que vous aimez exactement — apprendre, collectionner, classer, comprendre comment ça marche ? » « Racontez-moi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet ? » (et observer le niveau de détail et l'exhaustivité)		
Envahissement : l'intérêt occupe une place centrale et empiète sur le reste.	☒	☐
⌚ Y consacre tant de temps que d'autres activités, obligations ou relations en pâtissent ; structure la journée, voire l'identité. C'est ce retentissement — pas la passion en soi — qui distingue du hobby d'un passionné « ordinaire ». ⌚ « Combien de place ça prend dans vos journées ? Est-ce que ça déborde parfois sur le reste — travail, sommeil, proches ? » « S'il faut choisir entre ce sujet et autre chose — une sortie, une obligation —, qu'est-ce qui l'emporte, en général ? »		
En parle de façon intarissable, peu modulée selon l'interlocuteur.	☒	☐
⌚ Monologue enthousiaste (« info-dumping »), difficulté à s'arrêter ou à doser selon l'autre, ici on cible le débordement autour de l'intérêt. ⌚ « Quand vous parlez de ce sujet, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous en parliez beaucoup, ou trop ? » « Vous arrivez à vous arrêter facilement, ou c'est dur une fois lancé ? »		
- THEME 7 : LA SENSORIALITE -		
Nous recherchons des particularités du traitement sensoriel (hyper-, hypo-réactivité, recherche), dissociées d'un usage fonctionnel et retentissant au quotidien.		
Hyper-réactivité : certaines sensations provoquent une gêne ou une douleur disproportionnée.	☒	☐
⌚ Sons, lumières, textures / étiquettes, odeurs, toucher léger ou inattendu. Profil étendu, ancien, multimodal — pas une misophonie isolée (ex. seul le bruit de mastication), ni une simple gêne situationnelle d'anxiété. ⌚ « Comment ça se passe pour vous dans un endroit bruyant ou très éclairé — un supermarché, un open-space ? » « Le contact physique pas anticipé, une main sur l'épaule par exemple, ça vous fait quoi ? »		
Hypo-réactivité : perçoit peu ou tard des stimuli pourtant marqués	☒	☐
⌚ Blessures, brûlures, chaud / froid intenses peu ou pas ressentis ; ne réagit pas à des bruits forts. Vraie diminution de réactivité (ex. découvre une plaie sans l'avoir sentie), à distinguer d'un stoïcisme ou d'une banalisation. ⌚ « Vous est-il arrivé de vous blesser ou de vous brûler sans vous en rendre compte sur le moment ? » « Est-ce qu'on vous fait remarquer que vous êtes en t-shirt quand il fait froid — ou l'inverse — comme si vous ne sentiez pas ces choses-là ? »		
Recherche ou fascination sensorielle, sans but fonctionnel.	☒	☐
⌚ Touche / frotte / sent des matières pour la sensation, fixe longuement lumières, reflets, motifs, mouvements (eau, ventilateur). Recherche auto-régulatrice ou de plaisir sensoriel, distincte d'un loisir ou d'une appréciation esthétique ponctuelle. ⌚ « Y a-t-il des matières ou des objets que vous aimez toucher, frotter ou sentir, juste pour la sensation ? » « Est-ce qu'il vous arrive de rester un long moment à regarder quelque chose — une lumière, un mouvement, un motif — parce que c'est agréable ou apaisant ? »		
- THEME 8 : LES FONCTIONS COGNITIVES -		
Nous recherchons un style cognitif rigide et « local » (flexibilité, persévération, cohérence centrale, attention), retentissant au quotidien.		
Persévération : maintient une stratégie inefficace, peine à en changer.	☒	☐
⌚ Refait la même action sans effet plutôt que d'essayer autrement, ou abandonne en bloc. À distinguer d'une simple ténacité : ici l'absence d'alternative est subie. ⌚ « Quand quelque chose ne marche pas du premier coup, vous insistez de la même façon, ou vous essayez autrement ? » « Vous est-il déjà arrivé de vous obstiner sur une méthode alors qu'elle ne donnait rien ? »		
Cohérence centrale faible : se perd dans les détails, peine à dégager l'essentiel.	☒	☐
⌚ Traitement « local » : voit l'arbre avant la forêt, s'attarde sur des détails que les autres négligent, difficulté à résumer ou à hiérarchiser. Observable aussi dans la façon de raconter pendant l'entretien. ⌚ « Quand vous découvrez quelque chose de nouveau, vous commencez par les détails ou par la vue d'ensemble ? » « Est-ce qu'on vous dit que vous vous attardez sur des détails que les autres ne voient pas, ou que vous perdez de vue l'objectif global ? »		
Attention monotropique : fonctionne sur un seul canal à la fois ; transitions et interruptions coûteuses.	☒	☐
⌚ Traite une chose à la fois en profondeur ; difficulté à diviser l'attention ou à passer d'une activité à l'autre ; l'interruption désorganise. L'hyperfocus n'oriente pas (le TDAH en a aussi) — ce qui évoque le TSA, c'est le coût des transitions et le caractère monotrope par défaut. Le TDAH papillonne plutôt entre plusieurs tâches inachevées. Recouvrement fréquent : repérer lequel domine. ⌚ « Quand vous êtes pris dans quelque chose, comment ça se passe si on vous interrompt ou si vous devez passer à autre chose ? » « Vous arrivez à mener plusieurs choses de front, ou vous avez besoin d'en finir une avant de commencer la suivante ? »		
Besoin de cadre explicite : peine à démarrer ou structurer une tâche ouverte sans consigne claire	☒	☐
⌚ Une tâche « débrouillez-vous » sans procédure génère blocage ou anxiété ; nettement plus à l'aise avec une marche à suivre. À ne pas confondre avec un simple manque d'expérience. ⌚ « Une tâche où on vous dit juste "faites comme vous voulez", sans consigne précise — ça vous va, ou c'est inconfortable ? » « Vous êtes plus à l'aise quand on vous donne une marche à suivre claire, ou quand on vous laisse improviser ? »		
- THEME 9 : ATYPIES MOTRICES -		
Nous recherchons des stéréotypes dans la sphère psychomotrice (maniérismes / posture corporelle).		
Mouvements répétitifs auto-régulateurs actuels, souvent discrets.	☒	☐
⌚ « Stimming » camouflé de l'adulte : balancer la jambe, triturer un objet, enrouler une mèche, se pincer / gratter, faire les cent pas, répéter un son tout bas — surtout sous stress, excitation ou concentration. Fonction d'apaisement ou de décharge. ⌚ « Quand vous êtes stressé, très concentré ou très content, y a-t-il des gestes que vous faites sans y penser, qui vous aident à vous canaliser ? » « Vous avez besoin de bouger, de manipuler quelque chose, ou de marcher pour réfléchir ou vous apaiser ? » « Enfant, est-ce que vous faisiez des gestes répétitifs : battre des mains quand vous étiez excité, vous balancer, tourner sur vous-même ? On vous l'a peut-être raconté »		
Maladresse ou trouble de la coordination — signe associé, non spécifique.	☒	☐
⌚ Fait tomber des objets, se cogne, difficultés de motricité fine (boutons, lacets), a marché / écrit tard. Fréquent dans le TSA mais tout autant dans le TDC / dyspraxie : ne compte pas comme un signe TSA en soi — à pondérer dans l'ensemble et à explorer comme comorbidité. ⌚ « Vous arrive-t-il souvent de faire tomber des choses, de vous cogner, ou d'avoir du mal avec des gestes fins comme les boutons ou les lacets ? »		

- PARTIE 2 -

ENTRETIEN AVEC UN PROCHE (PROCHE PARENT / ENFANCE 5-6 ANS)

Cette partie repose sur un **entretien avec un proche** ayant connu le patient durant son enfance. Elle vise à recueillir des éléments développementaux en lien avec les critères du TSA, qui ne sont pas toujours accessibles de manière fiable par l'auto-anamnèse. L'outil utilisé est l'ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview), un entretien standardisé rempli par le clinicien avec un proche (avec l'accord du patient). **En cas d'impossibilité, et avec l'accord du patient, le questionnaire peut être remis au proche pour être complété de manière autonome puis relu secondairement avec le clinicien.** Sous chaque item, une **reformulation simplifiée** accompagnée d'un exemple concret est proposée afin de faciliter la compréhension des questions. L'entretien comporte 20 items portant sur l'enfance, idéalement autour de l'âge de 5-6 ans (fin de maternelle – début de primaire). Lorsque le questionnaire est complété de manière autonome, il est recommandé au proche d'ajouter sur une feuille annexe des exemples illustrant les réponses positives ainsi qu'un bref témoignage décrivant comment était le patient durant son enfance. Ces éléments apportent souvent un éclairage clinique précieux pour l'interprétation du questionnaire.

QUI REMPLIT LE QUESTIONNAIRE ?	OUI	OUI, UN PEU	NON	NON CONNU
DOMAINE 1 : Atteintes des interactions sociales réciproques				
Présente-t-il / elle des difficultés importantes d'interaction avec ses pairs ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle a toujours eu du mal à aller vers les autres ou à avoir des échanges naturels avec des personnes de son âge ?</i> « Restait souvent seul(e) dans son coin à la récréation ; ne se mêlait pas aux jeux de groupe, ou tournait autour sans y entrer. »				
Présente-t-il/elle peu d'intérêt ou un manque d'intérêt à se faire des amis ou à interagir avec ses pairs ?	☒	☐	☒	☐
<i>Avez-vous l'impression qu'il/elle s'intéresse peu aux autres ? Qu'il/elle n'a jamais vraiment cherché à avoir des amis ?</i> « Ne réclamait jamais d'inviter des copains, ne semblait pas gêné(e) de rester seul(e) ; quand il y avait des amis, l'initiative venait des autres »				
A-t-il/elle des difficultés à se rendre compte des signaux sociaux ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle ne remarque pas quand une personne est mal à l'aise, triste ou énervée ? A-t-il/elle du mal à comprendre les sous-entendus ou le second degré ?</i> « Continuait à parler sans voir que les autres décrochaient ; ne remarquait pas qu'un copain était fâché ou triste. »				
Présente-t-il/elle des conduites inappropriées sur le plan social ou émotionnel ?	☒	☐	☒	☐
<i>A-t-il/elle des réactions étranges ou décalées dans les échanges ? Parler très fort sans se rendre compte, ou couper souvent la parole ?</i> « Il/elle rit dans des situations sérieuses, ou se met en colère sans que les autres comprennent pourquoi »				
Q1 - Au moins 2 symptômes OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 2 : Engouement pour un (des) centre(s) d'intérêt restreint(s)				
Existe-t-il un centre d'intérêt ou un intérêt spécifique qui lui prend beaucoup de temps, au point que le temps pour d'autres activités s'en trouve très réduit ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle passe beaucoup (trop) de temps sur un sujet ou une activité précise, sans se lasser ?</i> « Par ex, il/elle peut passer des heures à lire sur les trains, les dinosaures, ou jouer au même jeu vidéo, sans faire autre chose. »				
Ses centres d'intérêt ou son intérêt spécifique présentent-ils un caractère restreint ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce que ce sont des sujets très précis, pas toujours ceux que les autres partagent ?</i> « Il/elle aime un sujet très pointu comme les horaires de bus, les plaques d'immatriculation ou un seul chanteur. »				
Ses centres d'intérêt sont-ils basés sur la mémoire de ce qui est appris par cœur, plutôt que sur leur sens réel ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle apprend plein d'infos sur un sujet mais sans vraiment comprendre à quoi ça sert ?</i> « Il/elle peut réciter plein de dates historiques ou de noms de Pokémon, mais sans en discuter vraiment. »				
Q2 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 3 : Imposition de routines, rituels et intérêts				
Essaie-t-il / elle d'introduire et de s'imposer des routines, rituels ou intérêts à tel point que cela pose des problèmes pour lui-même / elle-même ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle a des habitudes très strictes et devient stressé(e) ou agacé(e) si on change quelque chose ?</i> « Il/elle veut toujours s'asseoir à la même place à table ou suivre le même chemin pour aller à l'école. Si on change, il/elle s'énervé »				
Essaie-t-il / elle d'introduire ou de s'imposer des routines, rituels ou intérêts à tel point que cela pose des problèmes pour les autres ?	☒	☐	☒	☐
<i>Est-ce qu'il/elle oblige les autres à suivre ses propres routines, ou que ses habitudes sont envahissantes pour l'entourage ?</i> « Il/elle impose qu'on regarde les mêmes vidéos, qu'on fasse les choses dans un certain ordre. Il/elle interrompt les autres s'ils font autrement »				
Q3 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐

DOMAINE 4 : Particularités de la parole ou du langage				
Le développement de son langage a-t-il été retardé ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ A-t-il/elle parlé plus tard que les autres enfants ? Les premiers mots ou phrases sont-ils arrivés tard ?</i> ☐ « Il/elle n'a dit ses premiers mots qu'après 2 ans, ou ne faisait pas de phrases à 3 ans. »				
Son langage est-il "superficiellement parfait" : riche, élaboré, avec parfois des tournures compliquées, mais avec des difficultés pour comprendre les autres ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle utilise des mots compliqués ou parle comme un adulte, mais ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit ?</i> ☐ « Il/elle utilise des mots très soutenus comme "ceci étant" ou "néanmoins", mais ne comprend pas quand on lui parle de façon simple. »				
Son langage est-il "sonné", pédant ou "trop adulte" ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle parle d'une façon un peu étrange, trop sérieuse ou trop formelle pour son âge ?</i> ☐ « Il/elle parle comme un présentateur télé ou comme s'il/elle récitait une leçon. »				
Y a-t-il des caractéristiques de sa voix que vous trouvez particulières ou inhabituelles ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce que sa voix est monotone, très aiguë, trop forte, ou que le rythme ou l'intonation sont étranges ?</i> ☐ « Il/elle parle toujours très fort, ou au contraire tout doucement, ou met l'intonation "à côté" dans les phrases. »				
Présente-t-il / elle des troubles de compréhension (notamment contresens, prise au pied de la lettre) ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle prend tout au premier degré, ou comprend mal les blagues, l'ironie ou les expressions ?</i> ☐ « Si on dit "il pleut des cordes", il/elle regarde par la fenêtre pour chercher des cordes. »				
Q4 - Au moins 3 symptômes OUI ou OUI, UN PEU ?		☒	☐	☐
DOMAINE 5 : Troubles de la communication non verbale				
Fait-il / elle un usage limité des gestes ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle utilise peu les mains ou le corps pour accompagner ce qu'il/elle dit ?</i> ☐ « Il/elle ne fait presque jamais de gestes pour dire bonjour, montrer quelque chose, ou accompagner une explication. »				
Ses gestes sont-ils embarrassés, gauches, maladroits, étranges ou inhabituels ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce que ses gestes vous paraissent bizarres, décalés ou mal coordonnés ?</i> ☐ « Gestes raides ou décalés : pointe en tendant tout le bras, fait "coucou" de façon mécanique, mouvements un peu robotiques. »				
Ses expressions faciales sont-elles plutôt limitées à un petit répertoire ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce que son visage change peu quand il/elle parle ou ressent quelque chose ?</i> ☐ « Il/elle garde souvent le même visage, même en parlant de choses tristes ou drôles. »				
Son expression générale (y compris faciale) est-elle parfois inappropriée ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle sourit ou rit dans des moments où ce n'est pas adapté ?</i> ☐ « Il/elle rigole parfois quand quelqu'un parle de quelque chose de grave ou ne montre aucune réaction dans des situations émouvantes. »				
Son regard est-il distant, étrange, particulier, anormal ou bizarre ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'il/elle regarde peu dans les yeux, ou au contraire fixe trop intensément, ou a un regard difficile à soutenir ?</i> ☐ « Ne regardait pas dans les yeux quand on lui parlait, fixait à côté ou par terre ; ou au contraire fixait intensément sans jamais détourner. »				
Q5 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?		☒	☐	☐
DOMAINE 6 : Maladresse motrice				
A-t-il / elle été remarqué(e) comme fonctionnant mal sur le plan psychomoteur lors des évaluations soit dans le passé ou actuellement ?	☒	☐	☐	☐
<i>⓪ Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il/elle était maladroite(e), qu'il/elle bougeait "bizarrement" ou qu'il/elle avait du mal avec des gestes du quotidien ?</i> ☐ « Il/elle tombe souvent, a du mal à rattraper un ballon, ou à boutonner une chemise. » ☐ « Il/elle a marché tard, ou on a eu des remarques à l'école sur sa manière d'écrire ou de courir. »				
Q6 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?		☒	☐	☐

Si les réponses "OUI" ont été cochées aux questions de synthèse des 6 domaines (Q1 à Q6), alors le test est en faveur d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Cette évaluation contribue à l'argumentaire diagnostique, mais ne peut se suffire à elle seule : elle s'intègre dans une **appréciation clinique globale**, tenant compte de l'ensemble du parcours développemental et du fonctionnement actuel de la personne.

- PARTIE 2 BIS - ENTRETIEN AVEC UN PROCHE (PROCHE NON-PARENT)

Ce questionnaire repose entretien **avec un proche non-parent** (fratrie, conjoint-e, ami-e, colocataire) connaissant bien **le patient et son quotidien**, mais ne disposant pas de souvenirs fiables de sa petite enfance. Elle vise à recueillir **un regard externe** sur son fonctionnement actuel et au cours des années, en lien avec les critères du TSA, qui ne sont pas toujours accessibles de manière fiable par l'auto-anamnèse. L'outil utilisé est **l'ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview)**, ici adapté. Il est rempli par le clinicien avec le proche (avec l'accord du patient). **En cas d'impossibilité, le questionnaire peut être remis au proche pour être complété de manière autonome puis relu secondairement avec le clinicien.** Sous chaque item, une reformulation simplifiée accompagnée d'un exemple concret est proposée afin de faciliter la compréhension des questions. L'entretien comporte 20 items. Contrairement à l'ASDI standard, les réponses portent sur **la période durant laquelle le proche connaît le patient ainsi que sur son fonctionnement actuel.** Les items concernant spécifiquement la petite enfance pourront être cotés « Non connu » lorsque les informations ne sont pas disponibles. **Lorsque le questionnaire est complété de manière autonome, il est recommandé au proche d'ajouter sur une feuille annexe des exemples illustrant les réponses positives ainsi qu'un bref témoignage décrivant le patient au quotidien et sur la période qu'il ou elle connaît.**

QUI REMPLIT LE QUESTIONNAIRE ?	OUI	OUI, UN PEU	NON	NON CONNU
DOMAINE 1 : Interactions sociales réciproques				
Du mal à aller vers les autres, à avoir des échanges naturels ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Est-ce qu'il/elle a toujours eu du mal à aller vers les autres ou à avoir des échanges naturels avec des personnes de son âge ?</i> ☐ En groupe ou en soirée, reste en retrait, n'entre pas dans les conversations, ou tourne autour sans s'y mêler. »				
Montre-t-il/elle peu d'intérêt à se faire des amis ou à côtoyer les autres ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 S'intéresse peu aux autres, ne cherche pas vraiment à créer ou entretenir des liens ?</i> ☐ Ne propose jamais de voir du monde, pas gêné(e) de rester seul(e) ; l'initiative des relations vient des autres. »				
A-t-il/elle des difficultés à percevoir les signaux sociaux ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Ne remarque pas qu'on est gêné, triste, agacé ? Rate les sous-entendus, le second degré ?</i> ☐ « Continue de parler sans voir que l'autre décroche ; ne capte pas l'ironie. »				
A-t-il/elle des conduites inappropriées sur le plan social ou émotionnel ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Réactions décalées : parler trop fort, couper la parole, réagir "à côté" ?</i> ☐ « Rit dans un moment sérieux, ou s'emporte sans que l'entourage comprenne pourquoi. »				
Q1 - Au moins 2 symptômes OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 2 : Intérêt(s) restreint(s)				
A-t-il/elle un centre d'intérêt qui lui prend tant de temps que le reste en pâtit ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Beaucoup (trop) de temps sur un sujet précis, sans s'en lasser ?</i> ☐ « Y passe des heures — un jeu, un sujet, une collection — au point de délaisser le reste. »				
Ses centres d'intérêt sont-ils restreints / très spécifiques ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Des sujets très pointus, pas forcément partagés autour de lui/elle ?</i> ☐ « S'absorbe dans un domaine précis : un seul artiste, un type de matériel, des horaires, un système. »				
Ses connaissances reposent-elles sur l'accumulation par cœur plus que sur le sens ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Accumule quantité d'infos exactes sans en discuter le sens ?</i> ☐ « Récite des faits, dates ou détails précis, sans vraiment échanger autour. »				
Q2 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 3 : Imposition de routines, rituels et intérêts				
Impose-t-il/elle des routines au point que ça lui pose problème à lui/elle-même ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Habitudes très strictes, tendu(e) ou contrarié(e) si on les bouscule ?</i> ☐ « Tient à un ordre précis ; un changement le/la braque ou le/la bloque. »				
Impose-t-il/elle ses routines au point que ça pose problème aux autres ?	☒	☐	☒	☐
<i>🕒 Oblige l'entourage à suivre ses façons de faire, jusqu'à l'envahissement ?</i> ☐ « Exige qu'on range ou qu'on fasse les choses dans son ordre ; s'agace si quelqu'un dévie. »				
Q3 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐

DOMAINE 4 : Particularités de la parole ou du langage				
Son langage a-t-il été retardé dans l'enfance ? (seulement si connu)	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ À votre connaissance, a-t-il/elle parlé tard ? Sinon → « Non connu ».</i> ☐ « Il/elle n'a dit ses premiers mots qu'après 2 ans, ou ne faisait pas de phrases à 3 ans. »				
Son langage est-il "superficiellement parfait" : riche, élaboré, avec parfois des tournures compliquées, mais avec des difficultés pour comprendre les autres ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Langage très soutenu, mais comprend mal ce qu'on lui dit simplement ?</i> ☐ « Manie des tournures recherchées, mais rate le sens d'un message simple ou implicite. »				
Son langage est-il "sonné", pédant ou "trop adulte" ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce qu'il/elle parle d'une façon un peu étrange, trop sérieuse ou trop formelle pour son âge ?</i> ☐ « Il/elle parle comme un présentateur télé ou comme s'il/elle récitait une leçon. »				
Y a-t-il des caractéristiques de sa voix que vous trouvez particulières ou inhabituelles ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce que sa voix est monotone, très aiguë, trop forte, ou que le rythme ou l'intonation sont étranges ?</i> ☐ « Il/elle parle toujours très fort, ou au contraire tout doucement, ou met l'intonation "à côté" dans les phrases. »				
A-t-il/elle des troubles de compréhension (sens littéral, contresens) ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce qu'il/elle prend tout au premier degré, ou comprend mal les blagues, l'ironie ou les expressions ?</i> ☐ « Si on dit "il pleut des cordes", il/elle regarde par la fenêtre pour chercher des cordes. »				
Q4 - Au moins 3 symptômes OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 5 : Troubles de la communication non verbale				
Fait-il / elle un usage limité des gestes ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce qu'il/elle utilise peu les mains ou le corps pour accompagner ce qu'il/elle dit ?</i> ☐ « Il/elle ne fait presque jamais de gestes pour dire bonjour, montrer quelque chose, ou accompagner une explication. »				
Ses gestes sont-ils embarrassés, gauches, maladroits, étranges ou inhabituels ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce que ses gestes vous paraissent bizarres, décalés ou mal coordonnés ?</i> ☐ « Gestes raides ou décalés : pointe en tendant tout le bras, fait "coucou" de façon mécanique, mouvements un peu robotiques. »				
Ses expressions faciales sont-elles pauvres / peu variées ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce que son visage change peu quand il/elle parle ou ressent quelque chose ?</i> ☐ « Il/elle garde souvent le même visage, même en parlant de choses tristes ou drôles. »				
Son expression générale (y compris faciale) est-elle parfois inappropriée ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce qu'il/elle sourit ou rit dans des moments où ce n'est pas adapté ?</i> ☐ « Il/elle rigole parfois quand quelqu'un parle de quelque chose de grave ou ne montre aucune réaction dans des situations émouvantes. »				
Son regard est-il distant, étrange, particulier, anormal ou bizarre ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Est-ce qu'il/elle regarde peu dans les yeux, ou au contraire fixe trop intensément, ou a un regard difficile à soutenir ?</i> ☐ « Regarde à côté quand on lui parle, ou fixe intensément sans détourner. »				
Q5 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐
DOMAINE 6 : Maladresse motrice				
A-t-il/elle été remarqué(e) comme maladroit(e), par le passé ou actuellement ?	☒	☐	☐	☐
<i>⚠ Le trouvez-vous maladroit(e) au quotidien ?</i> ☐ « Il/elle tombe souvent, a du mal à rattraper un ballon, ou à boutonner une chemise. » ☐ « Fait tomber des objets, se cogne, peine avec les gestes fins (boutons, lacets), démarche un peu particulière. »				
Q6 - Au moins 1 symptôme OUI ou OUI, UN PEU ?	☒	☐	☒	☐

Si les réponses "OUI" ont été cochées aux questions de synthèse des 6 domaines (Q1 à Q6), alors le test est en faveur d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Cette évaluation contribue à l'argumentaire diagnostique, mais ne peut se suffire à elle seule : elle s'intègre dans une **appréciation clinique globale**, tenant compte de l'ensemble du parcours développemental et du fonctionnement actuel de la personne.

- ANNEXE A - ZOOM DSM

Cette annexe n'est **pas un questionnaire**, mais un **support clinique** pour éclairer le raisonnement diagnostique. Elle permet de relire les critères du **DSM-5** à la lumière des **éléments recueillis pendant l'évaluation**. Les manifestations doivent être **cliniquement significatives**, présentes **depuis l'enfance (même si atténuées)**, et non mieux expliquées par un autre trouble.

Critères		Manifestations possibles	Illustration
Critère A : Déficiences persistantes de la communication et des interactions sociales			
A1	Déficit de la réciprocité sociale et émotionnelle	Tendance à éviter ou écouter les conversations dites "superficielles" (small talk), souvent jugées confuses, peu intéressantes ou épuisantes.	À l'entretien, parle avec aisance et chaleur de son domaine, puis se ferme ou s'épuise dès qu'il faut "parler de tout et de rien". Au travail, jugé compétent mais "distant" ; déserte les échanges de couloir, qu'il trouve vains.
		Peine à entretenir un échange réciproque : ne relance pas, ne rebondit pas, ne demande pas de nouvelles en retour.	
		Apparente indifférence émotionnelle , mais souvent liée à un traitement cognitif ralenti ou saturé d'informations sociales à intégrer en temps réel.	
		Utilisation de stratégies compensatoires ou de "scripts sociaux" permettant de masquer temporairement les difficultés sociales, mais susceptibles de s'effondrer en cas de fatigue ou de surcharge sensorielle . Ces stratégies reposent souvent sur un surinvestissement cognitif dans l'interaction, en particulier chez les personnes qui masquent leurs difficultés (surveillance constante du regard, de la posture, du ton, du contenu verbal et des signaux de l'interlocuteur).	
		Anxiété ou inconfort dans les débuts de relation, comme la séduction ou l'amitié naissante.	
Ces difficultés peuvent être partiellement masquées chez des personnes verbales ou ayant un bon niveau d'adaptation sociale. Il est donc essentiel d'explorer la charge cognitive , l' inconfort interne ou la nécessité de routines d'interaction pour maintenir ces échanges.			
A2	Déficit de la communication non verbale	Contact visuel difficile ou évité (souvent perçu comme gênant, envahissant ou empêchant de se concentrer sur ce qu'on dit).	Regard fuyant ou au contraire trop appuyé en réunion ; voix monocorde qui fait dire "on ne sait jamais ce qu'il pense" ; ou, chez un sujet camouflé, sourires et hochements un peu plaqués qui se relâchent dès la fatigue.
		Expressions du visage peu nuancées ou peu congruentes avec ce qui est dit (ex. : visage figé ou sourire inadéquat).	
		Gestes pauvres ou désynchronisés par rapport au discours (ex. : ne montre pas du doigt, ne hoche pas la tête, posture rigide ou décalée).	
		Difficultés à moduler la voix (ton, volume, rythme ou intonation), ce qui donne parfois une impression de monotonie , d' exagération ou d' inadéquation émotionnelle.	
		Certains peuvent imiter ou surjouer les signaux sociaux appris (sourire à tout moment, cligner exagérément des yeux, ton exagérément dramatique, etc.), notamment chez les personnes avec "haut niveau de camouflage".	
Chez certaines personnes, ces signes sont masqués par des stratégies conscientes (camouflage social), en particulier celles ayant appris à observer et reproduire les signaux non verbaux. Ces efforts peuvent être cognitivement épuisants , et l' inadéquation réapparaît souvent en cas de fatigue ou de relâchement du contrôle volontaire .			
A3	Déficiences du développement du maintien et de la compréhension des relations	Peu ou pas d'initiative relationnelle : difficulté à aller spontanément vers les autres pour créer ou entretenir des liens, même s'il existe un désir de relation.	Peu d'amis, des liens qui s'étiolent faute d'entretien, ou des "amis" à peine connus rencontrés autour d'un intérêt. En réunion, perçu comme trop direct ou "à côté" ; comprend mal pourquoi une remarque a "mal pris".
		Ne module pas son comportement selon le contexte : mêmes registres avec un proche, un supérieur, un inconnu ; trop familier ou trop distant.	
		Relations amicales atypiques ou unilatérales : difficulté à comprendre ce qu'implique une relation réciproque ; relations souvent centrées sur un intérêt commun, ou vécues comme absolues (soit « ami », soit « ennemi »)...	
		Absence ou pauvreté des jeux partagés ou imaginatifs dans l'enfance : difficultés à construire un imaginaire commun, à adapter les rôles, ou à jouer selon des règles souples et partagées.	
		Problèmes de compréhension des règles implicites : ne pas saisir pourquoi une remarque est déplacée, pourquoi un comportement gêne, ou insister pour suivre des règles de manière rigide.	
Ce critère n'exclut pas la présence de relations entre personnes autistes. De nombreux adultes avec TSA peuvent créer des liens dans des contextes spécifiques sans que cela invalide les difficultés observées ailleurs. Les comportements doivent être interprétés à la lumière du développement, du milieu culturel, et du fonctionnement global.			
Les critères A1, A2 et A3 doivent tous être présents. Pour chaque sous-critère, une seule ligne clairement cochée avec des exemples cliniques probants suffit à le considérer comme rempli. Mais attention : - Ne pas cocher sur de simples impressions générales ou vagues et vérifier que la manifestation est persistante (présente dès l'enfance, même si elle s'est atténuée ou masquée aujourd'hui),  Prendre en compte le camouflage social : certains patients ont appris à masquer leurs difficultés en imitant ou en compensant (sourires automatiques, regard forcé, "scripts sociaux", etc.). Cela peut donner une impression trompeuse de fluidité sociale alors qu'il s'agit d'un effort coûteux, non spontané. Ces stratégies ne doivent pas faire sous-estimer la réalité des troubles.  L'objectif est qualitatif : il vaut mieux un signe bien décrit, clair et impactant, qu'une addition de manifestations légères ou floues.			

Critère B : Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités					
B1	Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de	Mouvements répétitifs : battre des mains, se balancer, marcher en rond, secouer les mains ou les doigts...	Chez l'adulte, les stéréotypies franches s'atténuent ou se masquent (balancement discret, jambe qui bat) ; persistent souvent un langage stéréotypé (mêmes formules, répliques de films) et un rapport très ordonné aux objets.	☐	
		Langage répétitif : écholalie, répétition immédiate ou différée de mots entendus, utilisation de « toi » pour parler de soi, utilisation stéréotypée de mots, de phrases ou de modes prosodiques.		☐	
		Utilisation inhabituelle d'objets : aligner des jouets, trier par couleurs ou formes, collectionner des objets de manière rigide, sans les utiliser pour leur fonction première. Chez l'adulte, cela peut prendre la forme de collections très organisées, d'obsession pour le rangement ou de routines mentales rigides		☐	
		Ces comportements ne sont pas "bizarres" ou inutiles : ils ont souvent une fonction régulatrice, permettent de se concentrer, de s'apaiser ou d'organiser un monde trop flou ou imprévisible. Les supprimer sans alternative peut causer un grand mal-être.			
B2	Intolérance au changement, adhésion inflexible à	Routines rigides et préférence pour l'identique : besoin de faire les choses toujours de la même manière (chemin, ordre, horaire) et tendance à choisir systématiquement les mêmes vêtements, aliments ou activités. Ces répétitions offrent des repères sécurisants et prévisibles.	Mêmes trajets, mêmes plats, matinée millimétrée ; un imprévu — réunion déplacée, route barrée, plat indisponible — déclenche une irritation ou une désorganisation hors de proportion.	☐	
		Rituels personnels ou sociaux : toujours dire bonjour de la même manière, avoir des phrases rituelles pour commencer ou terminer une interaction, gestes toujours identiques dans certaines situations.		☐	
		Intolérance au changement : détresse excessive ou désorganisation lors d'un imprévu ou d'un changement de programme (même mineur), que ce soit un objet déplacé, un emploi du temps modifié, un plat différent ou un trajet alternatif.		☐	
		Ces routines ne sont pas juste des "petites habitudes" : elles jouent un rôle d'ancrage majeur, permettant de compenser l'imprévisibilité de l'environnement. Les rompre sans ménagement peut déclencher de l'anxiété, voire une désorganisation importante.			
B3	Intérêts restreints, d'intensité ou de focalisation	Centres d'intérêt spécifiques et envahissants : intérêt intense pour un ou plusieurs sujets restreints ou atypiques (ex. : les horloges, les catastrophes naturelles, une série, un personnage, un système de classement, etc.). La personne connaît une quantité énorme de faits ou de détails sur ce sujet.	Chez l'adulte, l'intérêt paraît parfois banal (une série, un logiciel, la généalogie) mais occupe l'essentiel du temps libre et revient sans cesse dans la conversation ; le lien se crée surtout autour de ce sujet.	☐	
		Envie de partager ces savoirs : besoin de parler souvent (voire exclusivement) de ce sujet, sans se rendre compte si l'interlocuteur est intéressé ou non (parfois appelé "info-dumping").		☐	
		Lien social basé sur l'intérêt : plus à l'aise pour interagir avec les autres si le sujet du centre d'intérêt est partagé.		☐	
		Certains intérêts restreints sont socialement valorisés (musique, animaux, cause humanitaire, psychologie, etc.), en particulier chez les filles autistes, ce qui peut masquer leur caractère excessif ou exclusif. Ce n'est pas tant le contenu de l'intérêt qui est atypique, mais sa quantité, sa centralité et son intensité émotionnelle.			
B4	Hyper ou hypo réactivité aux stimulations sensorielles ou intérêt	Hypersensibilité : forte gêne ou douleur provoquée par des sons (ex. : bruits de bouche, aspirateur. Il ne s'agit pas d'une misophonie isolée - intolérance aux bruits générée par l'autre - par ex : bruit de mastication - mais d'une hypersensibilité sensorielle plus étendue.), la lumière, certaines textures (vêtements, étiquettes), des odeurs (produits ménagers, parfums), le toucher léger ou inattendu.	Porte casque/bouchons, fuit supermarchés et restaurants bruyants, ne supporte pas certaines matières ; ou à l'inverse ne sent pas une blessure, le froid, la faim ; ou reste fasciné par une lumière, une texture, un mouvement.	☐	
		Hypo-sensibilité : semble ne pas sentir certains stimuli – ne réagit pas à la douleur, au froid, ou aux odeurs fortes ; peut rechercher des sensations fortes pour compenser (par exemple se balancer, appuyer fort sur le corps, chercher des aliments très épicés).		☐	
		Comportements sensoriels particuliers : renifler les objets, toucher systématiquement certaines matières, observer longuement des jeux de lumière ou des motifs visuels (ex. : regarder fixement des mouvements d'eau ou de ventilateur).		☐	
		Ces particularités sensorielles sont extrêmement fréquentes chez les personnes autistes, et parfois sous-estimées. Elles peuvent fortement impacter la vie quotidienne, y compris la capacité à rester en classe, à faire les courses ou à tolérer les soins médicaux.			
Au moins 2 sous-critères doivent être présents. Pour chaque sous-critère, une seule ligne clairement cochée avec des exemples cliniques probants suffit à le considérer comme rempli .					

- ANNEXE B -

LES DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS ET/OU ASSOCIES

Le TSA sans déficience intellectuelle partage des traits avec d'autres troubles, ce qui rend son repérage à l'âge adulte parfois difficile. Certains tableaux peuvent l'**imiter**, d'autres **coexister** avec lui.

💡 **Clé clinique** : les signes du TSA sont **précoces**, **stables** et **présents dans divers contextes**. Le diagnostic repose sur une **convergence de signes**, leur **ancienneté**, leur **retentissement**, et leur **spécificité**.

- TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT, A EXPLORER SYSTEMATIQUEMENT -

Points communs avec les TSA	Différenciation
Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)	
Difficultés attentionnelles, impulsivité verbale, maladresses sociales, comportements inadaptés.	Dans le TDAH, les difficultés sociales sont secondaires (inattention, impulsivité) mais l'intention sociale est généralement préservée . Le regard est évité par distracted ou anxiété , mais pas par défaut de réciprocité. La communication non verbale reste accessible , même si mal ajustée.
Trouble du développement intellectuel (TDI)	
Retards de développement, difficultés d'adaptation, limitations dans la communication.	Dans le TDI, les difficultés sociales et de communication sont généralement proportionnelles au niveau global de fonctionnement intellectuel. En revanche, dans le TSA sans déficience, les difficultés sociales sont qualitatives (déficit de réciprocité, rigidité, etc.) et ne s'expliquent <u>pas</u> uniquement par une limitation cognitive .
Troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographe, dyscalculie...)	
Isolement social secondaire, décrochage scolaire, anxiété de performance.	Les troubles des apprentissages affectent des domaines ciblés (lecture, écriture, calcul), sans atteinte globale de la réciprocité sociale ou de la flexibilité comportementale. Ces patients n'ont <u>pas</u> de particularités dans les interactions sociales dès l'enfance.
Troubles développementaux de la coordination (TDC / dyspraxie)	
Maladresse, difficulté dans les activités de la vie quotidienne, retrait social secondaire.	Les difficultés sont principalement motrices et visuo-spatiales . Le repli peut être <u>réactionnel</u> à ces limitations, mais la communication non verbale, la réciprocité sociale et la compréhension des codes sociaux sont globalement préservées .
Troubles du langage oral (dysphasie / trouble développemental du langage)	
Difficultés d'interaction, retrait social, trouble de la communication.	Ces troubles affectent les aspects formels du langage (phonologie, syntaxe, lexique) mais sans altération intrinsèque de la réciprocité sociale ou des intérêts restreints. <u>Dans le TSA</u> , les troubles de la communication sont pragmatiques , liés à l'ajustement à l'autre, au contexte , et à la compréhension des implicites .

- AUTRES TABLEAUX CLINIQUES FREQUEMMENT CONFONDUS OU ASSOCIES -

Troubles anxieux (phobie sociale, anxiété généralisée, etc.)	
Évitement du lien social, inhibition dans les interactions.	Dans l'anxiété, l'évitement repose sur la peur du jugement , avec une conscience du caractère problématique. <u>Dans le TSA</u> , il y a souvent un défaut d'accès intuitif à la réciprocité , et les difficultés sont présentes <u>dès l'enfance</u> , y compris en dehors de situations évaluées comme stressantes.
Troubles dissociatifs / psycho-traumatismes	
Retrait, hypervigilance, hypo-affectivité, rigidité.	Ces troubles s'inscrivent dans une histoire de rupture, de trauma , et peuvent se manifester de façon discontinue . <u>Dans le TSA</u> , les altérations sont stables, développementales et présentes dès l'enfance .
Troubles des conduites alimentaires (notamment anorexie mentale restrictive)	
Rigidité, traits obsessionnels, centration sur des routines.	Dans l'anorexie, les comportements sont orientés vers le contrôle de l'image corporelle . Les préoccupations sont généralement partagées par le patient. <u>Dans le TSA</u> , les routines sont plus larges, désocialisées , et non centrées sur le corps .
Schizophrénie (formes précoces ou atypiques)	
Retrait social, bizarreries comportementales ou langagières.	Dans la schizophrénie, il existe souvent une rupture avec un état antérieur , une désorganisation cognitive ou affective , et des symptômes positifs (idées délirantes, hallucinations). L'évolution est plus fluctuante . <u>Dans le TSA</u> , la trajectoire est continue et les particularités sont précoces .
Troubles de la personnalité (notamment borderline, évitante, schizoïde...)	
Instabilité relationnelle, retrait, rigidité.	Dans les troubles de la personnalité, l' expression émotionnelle est souvent conservée ou fluctuante , avec des conflits/quêtes identitaires . <u>Le TSA</u> se caractérise plutôt par une expressivité réduite , une stabilité relative du fonctionnement, et des particularités développementales stables.

Haut Potentiel Intellectuel (HPI)

⚠ Le HPI **n'est pas un trouble**, mais un **profil cognitif**. Il peut être exploré en cas de fonctionnement atypique ou de décalage avec les pairs.

Isolement, langage élaboré, hyper-focalisation sur certains sujets.	Le HPI ne s'accompagne <u>pas</u> d'altérations qualitatives de la communication non verbale ni de réciprocité sociale altérée dès l'enfance. Ce sont des personnes qui fonctionnent « trop bien ». Les difficultés relationnelles relèvent d'un décalage intellectuel plutôt que d'une incompréhension des codes sociaux . En l'absence de rigidité comportementale, de routines envahissantes ou de particularités sensorielles marquées, le profil ne relève pas d'un TSA (dans lequel le fonctionnement est altéré). Le HPI peut toutefois coexister avec d'autres troubles (TDAH, troubles « dys », anxiété), ce qui peut complexifier l'évaluation.
---	---

- ANNEXE C -

GRILLE D'OBSERVATION PRATIQUE

Cette grille permet d'évaluer la qualité de l'interaction sociale en situation clinique. Elle s'appuie sur l'observation directe du patient. À remplir pendant ou immédiatement après l'entretien, en notant les éléments spontanément observés. Les items peuvent être pré-remplis si certaines informations sont déjà connues, pour concentrer l'échange sur les zones à explorer.

	OBSERVÉ	NON OBSERVÉ	INCERTAIN		
- RÉCIPROCITÉ CONVERSATIONNELLE -					
Échange peu réciproque (le « ping-pong » ne tient pas ; vous portez seul la dynamique).	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : réponses brèves, peu de relances ou de commentaires spontanés. 💡 Astuce : posez une question ouverte non médicale en début d'entretien (week-end, métier, passion), puis faites silence sans relancer : voyez si le patient développe seul ou si l'échange retombe. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> INTERACTION FLUIDE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Je suis éducateur, mais là je suis en arrêt. » Médecin : « Ah, dans quel type de structure ? » Patient : « Un foyer pour jeunes en difficulté. C'est prenant, mais j'adore ça. » Médecin : « Vous avez l'air d'y être très investi. » Patient : « Oui, même si ça me manque un peu. » </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> INTERACTION LIMITÉE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Rien. » Médecin : « Vous travaillez ? Vous avez déjà travaillé ? » Patient : « Oui. » Médecin : « Dans quel domaine ? » Patient : « Informatique. » </td> </tr> </table>				INTERACTION FLUIDE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Je suis éducateur, mais là je suis en arrêt. » Médecin : « Ah, dans quel type de structure ? » Patient : « Un foyer pour jeunes en difficulté. C'est prenant, mais j'adore ça. » Médecin : « Vous avez l'air d'y être très investi. » Patient : « Oui, même si ça me manque un peu. »	INTERACTION LIMITÉE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Rien. » Médecin : « Vous travaillez ? Vous avez déjà travaillé ? » Patient : « Oui. » Médecin : « Dans quel domaine ? » Patient : « Informatique. »
INTERACTION FLUIDE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Je suis éducateur, mais là je suis en arrêt. » Médecin : « Ah, dans quel type de structure ? » Patient : « Un foyer pour jeunes en difficulté. C'est prenant, mais j'adore ça. » Médecin : « Vous avez l'air d'y être très investi. » Patient : « Oui, même si ça me manque un peu. »	INTERACTION LIMITÉE Médecin : « Et en ce moment, vous faites quoi dans la vie ? » Patient : « Rien. » Médecin : « Vous travaillez ? Vous avez déjà travaillé ? » Patient : « Oui. » Médecin : « Dans quel domaine ? » Patient : « Informatique. »				
- GESTUALITÉ -					
Gestes co-verbaux pauvres ou absents (ne mime pas, ne ponctue pas, ne montre pas en parlant).	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : mains immobiles, récit corporellement « plat ». Exemple : décrit son trajet (« je tourne à droite puis tout droit ») sans esquisser le moindre geste directionnel. 💡 Astuce : demandez-lui de décrire un itinéraire ou une manipulation (« comment vous venez ici ? », « comment vous faites votre café ? ») — tâche qui appelle spontanément des gestes chez la plupart des gens.					
Gestes sociaux conventionnels absents ou mécaniques (salutation, hochement, signe).	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : n'initie/ne répond pas aux gestes codés, ou ils paraissent mécaniques. Exemple : ne tend pas la main en retour, ou la tend de façon raide et sans regard ; hoche peu la tête pendant l'échange. 💡 Astuce : à l'accueil, saluez et tendez la main en premier et observez l'ajustement (timing, regard associé) ; notez aussi les rituels de clôture en fin de consultation.					
- TONUS & MOTRICITÉ -					
Posture rigide / figée (ou au contraire avachie, maintien atypique).	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : posture peu naturelle, qui ne varie pas. Exemple : ne tend pas la main en retour, ou la tend de façon raide et sans regard ; hoche peu la tête pendant l'échange. 💡 Astuce : observez le moment de l'installation (comment il s'assoit, ajuste la chaise) puis la stabilité posturale sur la durée.					
Mouvements répétitifs d'auto-régulation (balancement, triturer un objet, tapotements).	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : mouvement stéréotypé et identique, à fonction auto-régulatrice. ⚠️ ≠ agitation anxieuse (décharge de tension, variée) et ≠ instabilité TDAH (bouge sans cesse, motricité globale) : ici c'est la forme constante et répétée qui signe, et la survenue possible dans le plaisir autant que dans le stress. Exemple : balancement régulier du buste, battements ou petits mouvements répétitifs des doigts, mèche enroulée selon un schéma toujours identique. 💡 Astuce : c'est souvent masqué en consultation ; la meilleure fenêtre est un moment d'enthousiasme — laissez-le parler d'une passion et guettez un mouvement toujours de même forme. Le caractère stéréotypé (vs agitation variée) et l'apparition dans le plaisir plutôt que dans le stress sont ce qui oriente.					
- CONTACT VISUEL -					
Contact visuel atypique : fuyant, trop fixe/transperçant, ou non modulé.	✓ ☐	✗ ☐	? ☐		
① Explication : évitement, fixation sans détour, ou regard désynchronisé (absent aux moments clés : silence, émotion, humour). Exemple : baisse les yeux dès que vous le regardez ; ou vous fixe sans ciller, de façon gênante. 💡 Astuce : comparez le regard quand il parle vs quand vous parlez, puis ménagez un silence ou une remarque émotionnelle et voyez s'il cherche votre regard à ce moment-là. Vous pouvez soutenir brièvement son regard pour jauger sa réponse.					

- EXPRESSIONS FACIALES -

Visage peu expressif / émotion peu visible.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>Mimique pauvre, peu de variations</i> Exemple : visage neutre même en évoquant un événement fort. 💡 Astuce : amenez-le à raconter un souvenir marquant et relancez sur le ressenti (« et ça vous a fait quoi ? ») pour charger le canal facial.								
Discordance émotion / discours (visage neutre sur un récit triste, sourire à contretemps).	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>Incongruence entre contenu émotionnel et expression.</i> Exemple Raconte un événement triste avec un visage neutre, sans expression.								

- COMMUNICATION SOCIALE RÉCIPROQUE -

Absence de bavardage social spontané (pas de remarque légère qui « huile » l'échange).	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>S'en tient au strict factuel, ne commente pas le contexte (météo, déco, trajet).</i> Exemple : aucune remarque sur l'attente, la chaleur, le bureau — entre directement dans le motif. 💡 Astuce : glissez vous-même une remarque sociale légère (« pas trop galère pour vous garer ? ») et voyez s'il rebondit socialement ou répond de façon strictement littérale.								
Passivité face aux silences (ne relance pas, ne comble pas).	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>Reste en attente, malaise non géré.</i> Exemple : le blanc s'installe ; il attend que vous repreniez, sans gêne apparente ni initiative. 💡 Astuce : après une de ses réponses, laissez délibérément 3–4 s de silence (en notant quelque chose) et observez s'il relance ou reste passif.								
Ne réagit pas / réagit à côté face à l'humour et à la connivence.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>Prend une remarque légère au premier degré, ne rebondit pas sur un point commun.</i> Exemple : prend une boutade au pied de la lettre ; reste neutre quand vous évoquez un vécu partagé.. 💡 Astuce : placez un trait d'auto-dérision bienveillant (« vous êtes plus organisé que moi ! ») et notez le sourire/rebond ; si un point commun réel surgit, voyez s'il s'en saisit.								
Prosodie inhabituelle (ton monotone, débit haché/rapide, mélodie décalée).	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>voix « robotique », « chantante », « monocorde ».</i> 💡 Astuce : laissez-le parler longuement d'un sujet qu'il maîtrise (la prosodie atypique ressort mieux en discours spontané prolongé) ; relevez aussi ses propres retours.								
Communication globalement désynchronisée (« chacun joue de son côté »).	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
① Explication : <i>La communication est comme un orchestre : ce n'est pas un solo, mais un duo, un trio, voire un quatuor. Elle mobilise plusieurs instruments en même temps : le contenu sémantique, la prosodie, les mouvements du visage, les gestes ou la posture. Lorsqu'ils sont coordonnés et ajustés à l'échange, l'interaction est fluide et harmonieuse.</i> Exemple : Le patient varie son intonation, regarde son interlocuteur, réagit aux signaux non verbaux, accompagne ses paroles de gestes et adapte son comportement à la situation sociale. 💡 Astuce : Lors de l'entretien, observez si vous jouez ensemble ou chacun de votre côté. Quand la communication fonctionne bien, vous avez l'impression d'improviser une partition commune.								